



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

MODELO DE ANAMNESE PARA REGULAÇÃO – VERSÃO UNIVERSAL

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS:

Nome completo: _____

Idade: _____ anos

Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino

Comorbidades: _____

Município de origem: _____

Unidade solicitante: _____

Data/hora da solicitação de transferência: ____/____/____ às ____:____

Nome do Médico

Solicitante/NºCRM: _____

2. HISTÓRICO CLÍNICO ATUAL

2.1 Motivo/causa da internação: _____

2.2 Sintomas associados: _____

2.3 Tempo de início dos sintomas: _____ dias

2.4 NÍVEL DE CONSCIÊNCIA:

☐ Lúcido ☐ Confuso ☐ Sonolento ☐ Comatoso

2.5 VENTILAÇÃO:

☐ Espontânea

☐ O₂ suplementar em cateter

☐ O₂ suplementar em máscara

☐ VNI (Ventilação Não Invasiva)

☐ Ventilação Mecânica invasiva

2.6 HEMODINÂMICA:

☐ Estável ☐ Hipotenso com reposição volêmica ☐ Necessita de drogas vasoativas

2.7 FUNÇÃO RENAL:

☐ Preservada

☐ Insuficiência sem indicação de diálise

☐ Insuficiência com indicação de diálise

2.8 DÉFICIT NEUROLÓGICO AGUDO:

☐ Não ☐ Sim: Se sim, qual? _____

2.9 Eliminações:

☐ Diurese espontânea ☐ Diurese por SVD ☐ Anúrica

☐ Parada de eliminação de flatos e fezes

2.10 Capacidade funcional (ECOG): ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

3. INDICADORES DE GRAVIDADE (CLÍNICOS E TERAPÊUTICOS)

☐ Necessidade de suporte ventilatório ou oxigenação avançada

☐ Uso de noradrenalina/dobutamina ou outras aminas

☐ Disfunção de múltiplos órgãos

☐ Rebaixamento importante do nível de consciência

☐ Insuficiência renal aguda grave

☐ Risco cirúrgico elevado com instabilidade clínica

☐ Necessidade de antibioticoterapia venosa de amplo espectro

☐ Investigação diagnóstica especializada

☐ Falência de acesso vascular

☐ Impossibilidade de suporte clínico adequado na unidade de origem.

Qual: _____

4. TIPO DE LEITO

4.1 ☐ Leito de UTI (adulto, pediátrico, obstétrico...)

4.2 ☐ Leito clínico de enfermaria

4.3 ☐ Leito cirúrgico

4.4 ☐ Cuidados paliativos

4.5 ☐ Oncológico

4.6 ☐ Ortopédico

5. CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE SRAG/VRS?

5.1 Caso suspeito ou confirmado de SRAG/VRS: ☐ Sim ☐ Não

5.2 Situação respiratória aguda grave: ☐ Sim ☐ Não

☐ Febre (referida ou aferida)

☐ Tosse ou desconforto respiratório

☐ Saturação < 95% em ar ambiente

☐ Taquipneia ou tiragem / batimento de asa nasal

☐ RX/TC com infiltrado pulmonar

☐ Diagnóstico provável: ☐ COVID-19 ☐ Influenza ☐ Outros

VST (Vírus Sincicial Respiratório): ☐ Suspeito ☐ Confirmado ☐ Não se aplica

6. EXAMES COMPLEMENTARES COMPROVANDO GRAVIDADE

6.1 Gasometria (se disponível):

pH: _____ PaO₂: _____ PaCO₂: _____ Lactato: _____ HCO₃: _____

6.2 PCR ou Procalcitonina: _____

6.3 Creatinina: _____

6.4 Imagem relevante (especificar):

6.5 Outros exames que justificam a gravidade:

7. CONCLUSÃO MÉDICA

Paciente com quadro clínico de:

_____, apresentando sinais de gravidade como _____, com exames laboratoriais e/ou de imagem compatíveis.

Necessita de transferência para _____, visando suporte terapêutico não disponível na unidade atual.

8. CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE ASSISTENCIAL (Portaria nº 1.559/2008)

8.1 [] Prioridade Alta – risco iminente de vida ou agravamento súbito

8.2 [] Prioridade Moderada – necessita de internação, mas sem risco imediato

8.3 [] Prioridade Baixa – condição estável, sem necessidade urgente

8.4 [] Cuidados Paliativos / Terminalidade

ESCALA DE PERFORMANCE: ECOG

0 – Completamente ativo, capaz de realizar todas as suas atividades sem restrição (Karnofsky 90 – 100%)
1 – Restrição a atividades físicas rigorosas, é capaz de trabalhos leves e de natureza sedentária (Karnofsky 70 – 80%)
2 – Capaz de realizar todos os auto-cuidados, mas incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho; em pé aproximadamente 50% das horas em que o paciente está acordado (Karnofsky 50 – 60%)
3 – Capaz de realizar somente auto-cuidados limitados, confinado ao leito ou cadeira mais de 50% das horas em que o paciente está acordado (Karnofsky 30 – 40%)
4 – Completamente incapaz de realizar auto-cuidados básico, totalmente confinado ao leito e à cadeira (Karnofsky < 30%)

Assinatura e carimbo médico: _____